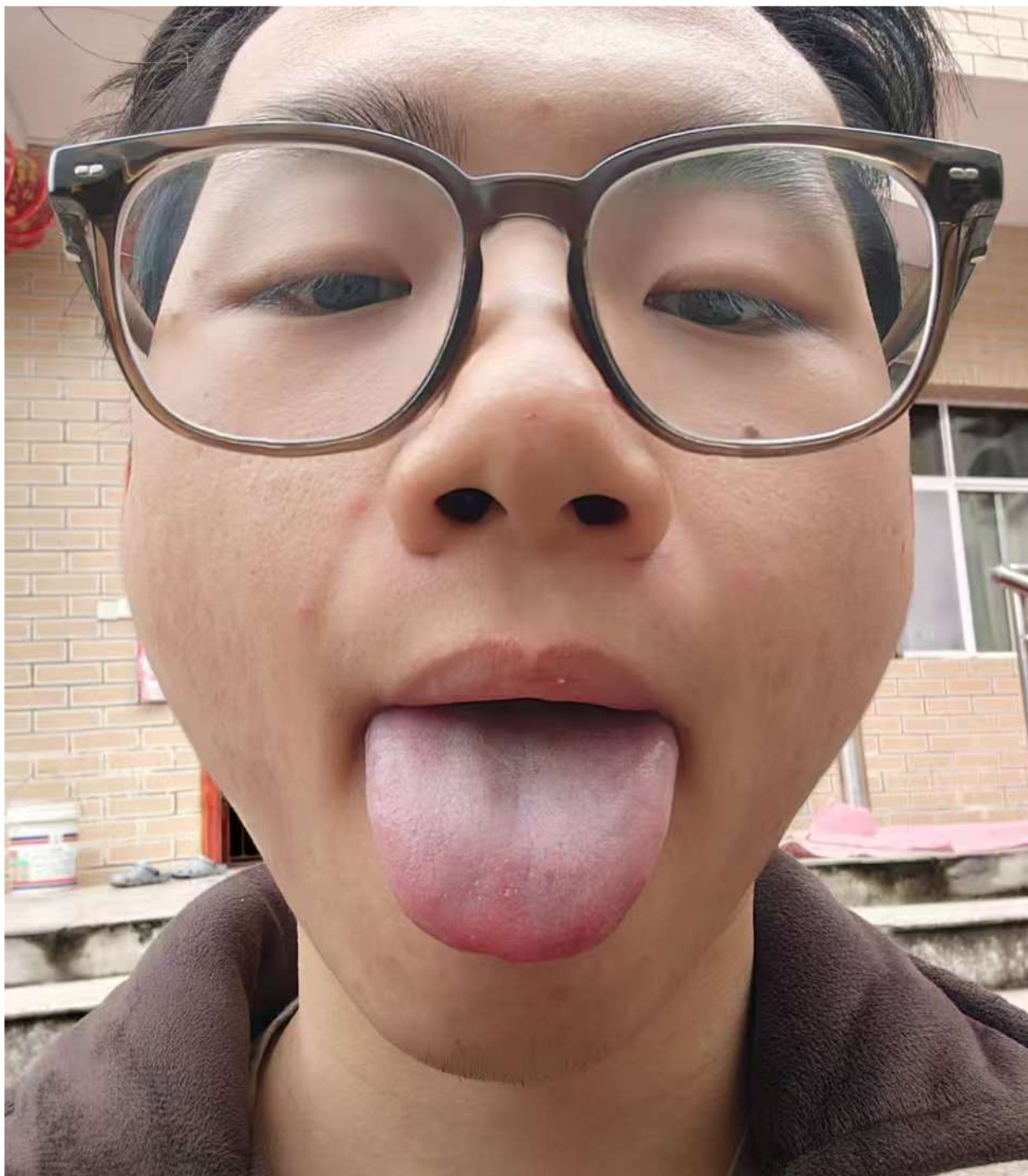


患者信息

姓名	张三丰	性别	男	年龄	19岁	生日	2006-03-23
住址	湖北省武当山特区						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）





舌苔图

分析提示【气滞血瘀】。特征识别：紫舌苔，舌质呈紫色，苔色深暗，多提示血瘀或寒凝血脉。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：平和质
置信度：37.8%

体质标签：
气血充足 呼吸均匀 体质平衡
气滞血瘀 湿热体质

问诊（症状问卷）

气虚质

切诊（脉搏检测）

心率：78.1 bpm
血氧：99 %

信号有效率：100 %
采样数：50

中医建议：

【脉象】缓脉（一息四至，不快不慢，从容和缓） 【主病】平人脉象，气血调和。

综合诊断建议

1. 体质判断

综合四诊结果，患者体质以**气虚质**为基础，兼有**气滞血瘀**与**湿热质**倾向。

望诊提示气滞血瘀（舌质紫暗）；

闻诊虽标注“平和质”，但置信度较低（0.38），且同时列出“气滞血瘀”“湿热体质”标签；

问诊明确指向气虚质；

切诊脉象和缓，提示整体气血尚调和，但局部可能存在瘀滞或湿阻。

结论：气虚质为主，兼夹气滞血瘀、湿热。

2. 主要证型分析

主要症状特点

气虚表现：可能易疲劳、气短、自汗、精力不足（问诊气虚质评分较高）。

气滞血瘀表现：舌质紫暗，提示气血运行不畅，可能伴有局部疼痛、情绪抑郁或月经不调（若为女性）。

湿热倾向：闻诊提示湿热体质，可能伴有口干苦、大便黏滞、皮肤油腻等问题。

证型判断依据

气虚证：问诊问卷结论为气虚质，评分中“qx”（气虚）分值为16（较高）。

气滞血瘀证：望诊舌质紫暗，为血瘀典型舌象；闻诊亦标注“气滞血瘀”。

湿热内蕴证：闻诊体质标签含“湿热体质”，可能因气虚运化无力，湿浊内生，郁而化热。

可能的证型组合

气虚血瘀，兼夹湿热。

气虚为本，导致气血运行无力而生瘀；气虚亦影响水湿运化，湿郁化热，形成虚实夹杂之证。

3. 调理建议

饮食调理

宜食：

补气食物：山药、小米、红枣、鸡肉、鲫鱼。

活血化瘀食物：山楂、黑木耳、玫瑰花茶、洋葱。

清热利湿食物：薏苡仁、赤小豆、冬瓜、绿豆芽。

忌食：

生冷油腻（如冰淇淋、肥肉），以免加重湿滞。

辛辣刺激（如辣椒、酒类），以免助热生湿。

过度滋补厚味（如阿胶、熟地），以免碍胃生湿。

生活起居

规律作息，避免熬夜（建议23点前入睡），以养气血。

保持情绪舒畅，避免长期压力或抑郁，以防气滞加重。

居住环境宜干燥通风，避免潮湿。

运动保健

选择缓和的有氧运动：如太极拳、八段锦、慢跑、散步，以益气活血，避免剧烈耗气。

每周3-4次，每次30分钟左右，以微汗为度。

穴位保健

足三里（双侧）：按揉或艾灸，每次5分钟，每日1-2次，以健脾益气。

合谷（双侧）+ **太冲**（双侧）：按揉各3分钟，每日1次，以理气活血、疏肝解郁。

阴陵泉（双侧）：按揉3分钟，每日1次，以健脾利湿。

中医药调理方向

治则：**益气活血，兼清湿热**。

可考虑方剂：**补阳还五汤**合**四妙丸**加减（需经中医师辨证后调整）。

中成药参考：**血府逐瘀胶囊**（活血化瘀）+ **参苓白术散**（健脾祛湿），但建议医师指导使用。

4. 注意事项

不可盲目服用活血破瘀药物（如三棱、莪术），以免耗气。

湿热表现明显时（如口苦、苔黄腻），需先清湿热，再渐进补气。

舌象紫暗若持续不减，需进一步排查器质性问题（如循环系统疾病）。

避免久坐不动，每小时起身活动5分钟，促进气血流通。

5. 建议复诊周期

初诊后2-4周复诊，评估舌象、症状变化及体质调整情况。

若症状明显改善，可调整为每1-2个月复诊一次；若瘀血或湿热征象加重，需及时复诊调整方案。

注：以上建议基于四诊信息整合分析，实际调理需在执业中医师面对面辨证后实施。

报告生成时间：2026/3/9 14:56:19

本报告仅供参考，请在医生指导下使用。